Calendrier vaccinal de l'adulte (usage hospitalier)

Reference	IMM-SCH-01 v2
Owner	Équipe opérationnelle d'hygiène
Approved by	Quality and Patient Safety Committee
Effective date	21/09/2026
Next review	21/09/2029
Applies to	All clinical areas of the Centre Hospitalier Saint-Aubin

1. Objet

Ce document résume les vaccinations à vérifier lors de toute consultation ou hospitalisation d'un adulte. Il complète, sans la remplacer, la recommandation nationale. Le statut vaccinal est évalué à la date de la consultation.

2. Vaccins et règles

Vaccin	Population	Règle
dTcaP (tétanos, diphtérie, coqueluche)	tous les adultes	rappel tous les 10 ans (à 10 ans révolus après la dernière dose)
Grippe saisonnière	tous les adultes de 65 ans et plus	une dose chaque saison, à partir du 15 octobre
Pneumocoque (PCV20)	65 ans et plus	une dose unique, sans rappel
Zona (vaccin recombinant, RZV)	65 ans et plus	2 doses espacées de 2 à 6 mois ; si l'intervalle de 6 mois est dépassé, administrer la seconde dose dès que possible sans reprendre le schéma
COVID-19	65 ans et plus	une dose chaque automne, à partir du 1er octobre

3. Interprétation

Un vaccin est « en retard » lorsque la date d'échéance est dépassée, « à faire » lorsqu'il est indiqué et jamais administré ou que la saison en cours n'est pas couverte, et « à jour » dans les autres cas. Les fenêtres d'intervalle se comptent en mois calendaires à partir de la date de la première dose.

4. Governance, audit and training

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.

5. Revision history

Version	Date	Author	Summary of change
1.0	21/09/2021	Équipe opérationnelle d'hygiène	First issue
2.0	21/09/2023	Équipe opérationnelle d'hygiène	Triennial review; format harmonised
3.0	21/06/2025	Équipe opérationnelle d'hygiène	Tables updated after clinical audit
current	21/09/2026	Équipe opérationnelle d'hygiène	Review and re-issue

Annex A. Implementation notes

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.

Annex B. Implementation notes

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.